

טבלה 12.5 הערכה נירולוגית לפי FAST

F	FACE	בדיקת סימטריה בפנים
A	ARMS	בדיקת הכוח בידים
S	SPEECH	בדיקת דיבור
T	TIME	כמה זמן נמשך המצב

עילפון (Syncope)

עילפון הוא מצב של חוסר הכרה זמני; נמשך פחות מ-5 דקות, ובדרך כלל פחות מדקה אחת.

הגורמים לעילפון

ההתעלפות נגרמת מהפרעה פתאומית באספקת דם למוח. כל הפרעה בהחזר ורידי עלול לגרום להתעלפות. העילפון הוא פתרון: כשלמוח אין אספקת חמצן מספקת הוא גורם לעילפון שמביא את האדם למצב של שכיבה - איזון - ובמצב זה זרימת הדם למוח יעילה הרבה יותר מאשר בעמידה.

תזכורת: כ- $\frac{3}{4}$ מנפח הדם נמצא בכל רגע במערכת הוורידית.

גורמים לעילפון הנוגעים למערכת הקרדיווסקולרית (טבלה 12.6)

- **גירוי ואזווגאלי** - גירוי של עצב הוואגוס שמשפיע על קוטר כלי הדם ופוגע ביכולת המכאנית לכווץ כלי דם → הרחבת כלי דם וירידה פתאומית בהחזר הדם הוורידים מהגוף אל הלב → מתרחשת ירידה פתאומית בלחץ דם הפוגעת באספקת הדם למוח. דוגמה לגירוי זה: שיעול חזק, ישיבה מאומצת בשירותים (Valsalva), ולסלבה=הפעלת לחץ תוך בטני תוך עצירת הנשימה, חרדה קיצונית, פחד עז, כאב חריג ועוד. תגובה ואזווגאלית היא הגורם לכ-50% מהמקרים של איבוד הכרה קצר.
- **לחץ דם אורטוסטטי (orthostatic hypotension)** - ירידת לחץ הדם מעבר לירידה הפיזיולוגית בשינוי תנוחה (לדוגמה: מעבר חד ומהיר משכיבה לעמידה); מצב זה שכיח בקרב מבוגרים הנוטלים תרופות למניעת יתר לחץ דם או באנשים במצב התייבשות או הסובלים מתת-לחץ דם באופן כרוני.
- **התעלפות בגלל רגישות יתר של הסינוס הקרוטידי (carotid sinus syncope)** - בייחוד בקשישים, ירידה באספקת החמצן למוח בשל רובד טרשתי בעורקים המספקים דם למוח.
- **תתנפח בכלי הדם** - לדוגמה בהלם תת-נפחי כאשר יש דימום או התייבשות.
- **ירידה בתפוקת הלב** - עלולה להיגרם בגלל מומים או פגיעות בשריר הלב: חסימה במוצא חדר שמאל (היצרות של מסתם אבי העורקים), חסימת מוצא חדר ימין, אוטם שריר הלב תסחיף ריאות ועוד.
- **הפרעות קצב הלב** - מכל סוג שהוא הגורמות לכך שהלב אינו פועל ביעילות, ולכן אינו מצליח ליצור לחץ דם מספק.

סיבות נוספות

- עייפות מתמשכת
- פציעה
- אנמיה
- היפוקסיה
- היפרוונטילציה
- היפוגליקמיה
- אירוע מוחי איסכמי חולף (transient ischemic attack: TIA)
- יש כמה מחלות שיכולות להידמות לעילפון ונמצאות באבחנה מبدלת לעילפון
- היפרוונטילציה
- היפוגליקמיה
- התקף חרדה
- פרכוס

טבלה 12.6 הגורמים לעילפון: לבביים ושאינים לבביים

גורמים לבביים ישירים	גורמים שאינים לבביים
גירוי וגאלי טהור (ללא גורמים ידועים)	לחץ נפשי, מתח, חרדה
הפרעות בקצב הלב	שינוי תנוחה מהיר
מחלות מסתמים (היצרות מסתם אאורטלי)	כאב
אוטם שריר הלב (MI)	היפוגליקמיה
תסחיף ריאות (PE), בדרך כלל לבבי	הרעלת סמים או אלכוהול

סימנים וסימפטומים

תחושות - רוב המטופלים יתלוננו על הרגשה כללית לא טובה: טשטוש, בלבול, נקודות שחורות מול העיניים, בחילות, הקאות וחיוורון. תחושה מקדימה בדרך כלל תארך כ־30 שניות, אך לעיתים לא תהיה תחושה מקדימה והעילפון יקרה באופן פתאומי (מתאים להפרעות קצב).

משך - עומק ומשך האירוע משתנה (בדרך כלל כמה שניות עד דקות) עד שהמטופל יחזור להכרה.

תנוחת המטופל - בדרך כלל יימצא בשכיבה, עם הרפיה מלאה של שרירי השלד. לעיתים אפשר לראות כיווצי שרירי שלד אחדים (נראים כמו פרכוס טוניקלונים אך קצרים הרבה יותר) שעשויים לבלבל עם פרכוסים.

שלא כמו בפרכוסים, בעילפון יש שליטה כמעט מלאה על סוגרים, בדרך כלל לא תופיע נשיכת לשון (וגם אם כן, תהיה זו נשיכה בקצה הלשון ולא בצידו) והחזרה להכרה עם תום העילפון תהיה מהירה מאוד - שניות עד דקות אחדות - לא תהיה תקופה פוסט־איקטלית.

מדדים - ייתכנו ממצאים של לחץ דם נמוך וטכיקרדיה.

הקלה על המטופל - בשכיבה הסימפטומים והסימנים נעלמים ואילו קימה בטרם עת עלולה להוביל לאירוע נוסף.
התאוששות - יש מטופלים שמתעוררים מייד ואחרים בהדרגה. כאבי ראש לאחר התעוררות הם מצב נפוץ וכנראה לא מסוכן.

הסכנות והסיבוכים של עילפון

בעת עילפון יש כמה סכנות למטופל והן נובעות מסיבוכים של איבוד ההכרה והנפילה:

- פגיעה בנתיב האוויר
- טראומה משנית לנפילה
- אספירציה

הטיפול

- טיפול לפי סכמת טיפול ABCDE (איור 12.6).

אם המטופל עדיין מחוסר הכרה הטיפול יכלול:

- פותחים נתיב אוויר
- נותנים חמצן אם הסטורציה נמוכה מ-94% או כשאין סטורציה
- מרימים רגליים
- בודקים סוכר
- מפנים, ותוך כדי הפינוי שוקלים החזר נוזלים וטיפול נוסף

אם המטופל חזר להכרה:

- נותנים חמצן אם מופיע קוצר נשימה או שהמטופל מתלונן על קושי בנשימה
- מרימים רגליים
- מפנים



- השכבת המטופל והרמת רגליו ב-30 מעלות
- תמיכה ב-ABC ומתן חמצן במסכה במידת הצורך
- חיפוש סיבה/גורם לעילפון
- בדיקת סוכר על מנת לשלול היפוגליקמיה
- לאחר התאוששות המטופל יש להקימו בהדרגה
- בשום אופן, אין להתיז מים או לסטור למטופל!
- בחשד לטראומה, יש לטפל עפ"י סכמת ה-PHTLS
- כל עוד המטופל מחוסר הכרה יש לפעול עפ"י סכמת ההחייאה

חשוב לזכור, עילפון הוא ביטוי קליני לבעיה אחרת לאחר הטיפול הראשוני, חפש את הגורם לעילפון וטפל בו

איור 12.6 הנחיות לטיפול במטופל שהתעלף

מצבי חירום סוכרתיים

סוכרת היא מחלה נפוצה מאוד בעולם המערבי. תפוצת המחלה הולכת וגדלה עם התקדמות הטכנולוגיה, בעיקר בגלל מזון מתועש, עתיר סוכר וחומצות שומן רוויות.

סוכרת (Diabetes Mellitus)

סוכרת היא מצב של חוסר איזון אנדוקריני (במערכת ההורמונים) הנובע מייצור חסר או ייצור לא תקין של ההורמון אינסולין בבלב או עמידות של הגוף לאינסולין. אם האינסולין אינו מבצע את משימתו יש עלייה של רמות הסוכר בדם ובשתן. מצב של עודף סוכר בדם (היפרגליקמיה) אינו בריא ועלול לפגוע באיברים רבים. מערכות רבות נפגעות לטווח ארוך עקב הסוכרת ובראשן המערכת הקרדיווסקולרית, הראייה ומערכת העצבים.

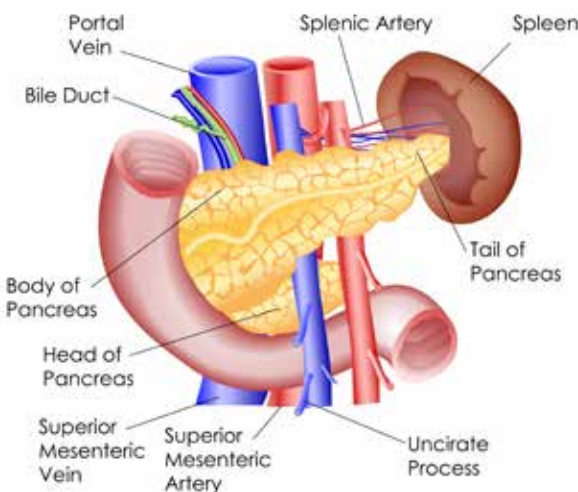
האיברים המשתתפים במנגנון הסוכרת

הלבלב - הנמצא בבטן העליונה משמאל, מאחורי הקיבה (איור 12.7) הוא בלוטת המפתח של המחלה במקרים שבהם הבעיה היא חוסר בייצור האינסולין (insulin dependent diabetes mellitus: IDDM). זוהי סוכרת סוג 1 (לדוגמה, סוכרת נעורים).

ללבלב תפקידים אנדוקריניים (הפרשת הורמונים) ואקסוקריניים (הפרשת חומרים כימיים פעילים למערכת העיכול). הנוזלים שבלוטה זו מפרישה בסיסיים מאוד (pH גבוה). התפקיד האקסוקריני (האנזימטי) של הלבלב הוא ליצור אנזימים הקשורים למערכת העיכול שתפקידם לסייע בעיכול מרכיבי מזון, בדגש על שומנים וחלבונים.

התפקיד האנדוקריני - אחראי על הפרשת הורמונים ישירות אל הדם והוא מורכב מכמה סוגי תאים: תאי אלפא, תאי בטא ותאי גמא (איור 12.8):

- תאי אלפא - תפקידם הוא ייצור ההורמון גלוקגון (glucagon).
- תאי בטא - תפקידם הוא ייצור ההורמון אינסולין (insulin).
- תאי גמא - תפקידם הוא ייצור ההורמון סומטוסטטין (soma-tostatin).



איור 12.7 הלבלב (Pancreas)

מקום הלבלב בגוף האדם, קרוב לתריסריון, הקיבה, הטחול והכבד.